

Le 09 mars 2023

COCHER LA OU LES REPONSES JUSTES :

- 1- Une jeune fille de 27 ans, suivie pour stérilité consulte pour métrorragies après 10 jours de retard des règles, votre examen clinique est normal, vous suspectez une grossesse extra-utérine, il faut :
- a- Revoir la patiente 4 ou 5 jours après ✗
 - b- Faire un dosage de progestéronémie ✗
 - c- Dosage de B-HCG et une échographie pelvienne ✓
 - d- Faire une hystérocopie ✗
- 2- Les examens demandés en matière de grossesse extra-utérine avant la rupture :
- a- Echographie ✓
 - b- Coelioscopie ✓
 - c- Hystérosalpingographie ✗
 - d- Colposcopie ✗
- 3- Le dispositif intra-utérin :
- a- Peut rester en place jusqu'à la ménopause ✗
 - b- Peut contenir un réservoir hormonal ✓
 - c- Contre indiqué en cas de myome intra-cavitaire ✓
 - d- Meilleure contraception chez la femme après 40 ans ✓
- 4- L'exploration d'un couple stérile repose :
- a- Spermocytogramme ✓
 - b- Hystérosalpingographie ✓
 - c- Coelio-hystérocopie ✓
 - d- Marqueurs tumoraux
- 5- Le diagnostic du cancer du sein repose sur :
- a- Téléthorax
 - b- Cytoponction
 - c- Mammographie ✓
 - d- Micro biopsie échoguidée ✓
- 6- Le nouveau-né d'une mère diabétique risque :
- a- Une hyperglycémie + hypocalcémie ✗
 - b- Hypercalcémie + hypoglycémie ✗
 - c- Une détresse respiratoire ✓
 - d- Lésions traumatiques lors des manœuvres obstétricales ✓
- 7- Les complications de la toxémie gravidique sont :
- a- Prééclampsie et éclampsie ✓ ^{HTP}
 - b- HELLP syndrome ✓
 - c- CIVD ✗
 - d- Hématome rétro-placentaire ✓

- 8- L'épreuve sur utérus cicatriciel nécessite :
- a- Un bassin perméable ✓
 - b- Une présentation de siège ✗
 - c- Espace inter-génésique supérieur à un 1 an ✓
 - d- Bloc opératoire à proximité ✓
- 9- Lors d'une rupture prématurée des membranes :
- a- Le risque d'accouchement prématuré est nul ✗
 - b- On a un risque infectieux important ✓
 - c- On tocolyse si la grossesse est à 38 semaines ✗
 - d- La surveillance est axée sur le risque infectieux et le risque de prématurité ✓
- 10- En cas d'incompatibilité fœto-maternelle dans le système rhésus :
- a- La patiente doit bénéficier d'une injection de sérum anti-D systématiquement avant la conception ✗
 - b- Le test de Coombs direct est pratiqué chez la mère après l'accouchement ✗
 - c- Le test de Coombs direct est pratiqué chez le nouveau-né ✓
 - d- L'injection de l'anti-D n'est pas essentielle en cas de prise quotidienne de vitamine D ✗
- 11- Dans les présentations défléchies, la présentation céphalique en déflexion moyenne :
- a- Est la présentation de front ✓
 - b- Est une présentation eutocique à la limite de la dystocie ✗
 - c- La confirmation du diagnostic nécessite une échographie ✓
 - d- Le diamètre de la présentation est le syncipito-mentonnier qui fait 13.5 cm ✓
- 12- Dans la présentation de front, l'accouchement par voie basse d'un fœtus à terme :
- a- Nécessite une direction du travail par les utérotoniques ✗
 - b- N'est pas contre indiqué chez la multipare ✗
 - c- L'engagement est facile ✗
 - d- Est contre indiqué du fait du risque d'enclavement ✓
- 13- La délivrance normale :
- a- Est l'étape la moins dangereuse dans l'accouchement ✗
 - b- Elle se fait à l'état normal dans un délai de 30 mn ✓
 - c- Le phénomène actif correspond à la reprise des contractions utérines après 10 à 15 mn qui vont finir le décollement placentaire ✓
 - d- Le mode Baudelocque correspond à l'expulsion du placenta par la face maternelle ✗
- 14- Au cours de la délivrance :
- a- Le décollement placentaire est confirmé par la manœuvre de déplissement du segment inférieur ✓
 - b- La migration du placenta se fait toujours par glissement quel que soit la localisation ✗
 - c- La ligature vivante de pinard intervient dans la phase d'hémostase ✓
 - d- La délivrance artificielle est indiquée si la délivrance ne se fait pas au bout d'une heure ✗
- 15- L'hémorragie de la délivrance :
- a- Définie par une spoliation sanguine de plus de 500 cc en cas d'accouchement par voie basse chez (anémique) ✗ 300
 - b- Ayant pour origine la zone d'insertion placentaire ✓
 - c- La ligature des artères hypogastriques est réalisée en premier lieu avec efficacité très élevée ✗
 - d- L'hystérectomie d'hémostase est systématique ✗

16- Madame xx âgée de 38 ans, poids 110 kg, taille 1 m 65, c'est une G4P2 (1 avortement, 1 mort In utéro 4 kg 600, 1 enfant vivant né par césarienne poids 4kg 700, consulte pour le suivi d'une grossesse de 24 semaines, l'échographie fœtale retrouve un hydramnios avec biométrie fœtale à 27 SA ; devant ce tableau :

- a- Faire une glycémie à jeun avec glycémie post-prandiale complétée par une hyperglycémie provoquée par voie orale ✓
- b- Faire une glycosurie avec hémoglobine glyquée pour poser le diagnostic X
- c- Introduire la corticothérapie pour la maturation pulmonaire X
- d- Intérêt d'un morphogramme détaillé ✓

17- Au cours de la grossesse diabétique :

- a- La première moitié de la grossesse est marquée par une insulïnémie basse X ↗
- b- L'insulinorésistance est marquée à partir de 16 semaines de grossesse ✓
- c- L'insuline passe la barrière placentaire entraînant un hyperinsulinisme fœtal X
- d- Les hypoglycémies ne sont pas tératogènes ✓

18- Madame xx âgée de 28 ans, sans antécédents particuliers consulte pour douleur pelvienne aiguë avec leucorrhées purulentes, j5 post hystéroscopie, à l'examen clinique : température 38.5, sensibilité pelvienne, devant ce tableau :

- a- Hospitalisation de la patiente, demande d'un bilan infectieux (FNS, CRP) ✓
- b- Administration d'une antibiothérapie bactéricide et synergique ✓
- c- Administration des anti-inflammatoires X
- d- Proposer une coelioscopie en absence d'amélioration ✓

19- Au cours des infections génitales :

- a- Le PH alcalin du vagin est un moyen de défense contre les infections X
- b- L'usage fréquent des antiseptiques locaux à un intérêt dans la prévention des infections à répétition X
- c- La glaire cervicale sécrétée par l'épithélium de l'endocol et riche en enzymes ✓ constitue un moyen de protection .
- d- La femme ménopausée est plus exposée aux infections à répétition X

20- Les infections génitales basses :

- a- Les leucorrhées blanchâtres en lait caillé avec prurit intense sont évocatrices d'une infection à trichomonas X *major*
- b- L'examen cyto bactériologique est systématique avant d'entamer le traitement .
- c- Le Gonocoque est responsable d'une infection urogénitale avec une symptomatologie importante ✓
- d- La chlamydia est responsable des leucorrhées verdâtres avec odeur de poisson pourri X *Gn de cell.*

21- Au cours des pathologies bénignes du sein, l'adénofibrome :

- a- Se développe à partir de l'unité terminale ducto-lobulaire ✓
- b- Est une pathologie de la femme ménopausée X
- c- Dans 70% des cas, il se localise au niveau du quadrant inféro--interne X *QSE*
- d- Sur le plan anatomopathologique, il s'agit d'une prolifération équilibrée épithéliale et conjonctive ✓

22- Les tumeurs phyllodes :

- a- Sont volontiers de taille importante ✓
- b- Se voient surtout chez les jeunes filles de moins de 20 ans X
- c- Nécessite un traitement médical par les progestatifs X
- d- Peuvent évoluer vers un sarcome mammaire en absence de prise en charge ✓

23- La contraception hormonale :

- a- Les oestroprogestatifs agissent en inhibant la prolifération endométriale et l'ascension des spermatozoïdes seulement ✗
- b- Les oestroprogestatifs normodosés sont utilisés comme méthode contraceptive avec meilleure tolérance ✗
- c- Les macroprogestatifs sont utilisés dans un but thérapeutique et contraceptif ✓
- d- Les microprogestatifs sont pris de façon continue à heure fixe ✓

24- Le dispositif intra-utérin :

- a- Le DIU hormonal libère des œstrogènes et des progestatifs en continu ✗
- b- Il est contre indiqué en cas d'antécédent de GEU ✓
- c- C'est la meilleure méthode contraceptive en cas de cardiopathie valvulaires contre indiquant la contraception hormonale ✗ *Contre indiquée*
- d- Il est inséré pendant la deuxième phase du cycle ✗

25- La péri-ménopause est marquée par :

- a- Des cycles courts avec accélération de la maturation folliculaire puis des cycles longs ✓
- b- Une aménorrhée définitive.
- c- Sa durée peut aller de quelques mois à une dizaine d'années ✓
- d- Taux de FSH bas ✗

26- Au cours de la ménopause, on retrouve :

- a- FSH élevé, œstradiol bas, inhibine élevée
- b- FSH élevé, œstradiol (élevé) inhibine élevée ✗
- c- FSH élevé, œstradiol bas, disparition de l'inhibine ✓
- d- FSH (bas), œstradiol bas, disparition de l'inhibine ✗

27- Le traitement hormonal substitutif :

- a- Indiquée pour corriger la carence progestative ✗ *œstro*
- b- Indiquée en cas d'insuffisance ovarienne primitive ✓
- c- Il est contre indiqué en cas de néo du sein ✓
- d- Nécessite une surveillance particulière ✓

28- Quel(s) est (sont) le(s) facteurs de risque de la grossesse extra utérine :

- a- Le tabac ✓
- b- Antécédents de GEU ✓
- c- Antécédents de salpingite aigue ✓
- d- La consommation d'alcool ✗

29- Une patiente de 27 ans se présente aux urgences pour des algies pelviennes (aigues), elle n'a pas d'ATCD particulier, elle prend une contraception microprogestative, elle est apyrétique. Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) : *= x 2 points*

- a- Le dosage des BHCG n'est pas un élément déterminant du diagnostic ✗
- b- La prise des constantes vitales doit être le premier geste de la prise en charge ✓
- c- L'utilisation d'une pilule microprogestative permet des oublis, à l'inverse d'une pilule oestroprogestative car elle bloque l'ovulation ✓
- d- Une échographie pelvienne est nécessaire à la démarche diagnostique ✓

30- Parmi les causes d'aménorrhée secondaires quelle(s) est (sont) la (les) plus fréquente(s) :

- a- Un syndrome de morsierkallman ✗
- b- Une aménorrhée hypothalamique ✓
- c- Un adénome a la prolactine ✓
- d- Une tuberculose génitale ✗

31- Quel(s) est (sont) l'(les) objectif(s) de la consultation prénatale ?

- a- Réaliser un examen clinique si nécessaire.
- b- Surveiller une pression artérielle.

- (5-15)
- c- Faire une mise au point sur le statut sérologique de la patiente .
 - d- Informer sur les bénéfices de l'automédication durant la grossesse X
- 32- Parmi les propositions suivantes relative au baby blues :
- a- Il survient dans les quatre semaines qui suivent l'accouchement X
 - b- Il est caractérisé par une labilité de l'humeur ✓
 - c- Il touche 30 % des femmes ✓
 - d- Elle a des conséquences sur le développement de l'enfant ✓
- 33- Quelles sont les affirmations vraies concernant le traitement dans les GEU :
- a- Des GEU avec Des BHCG ≥ 1500 ui/l ne peuvent qu'être traités chirurgicalement X
 - b- Un hématosalpinx est une indication formelle à la chirurgie ✓
 - c- Une GEU peu symptomatique peut être traitée médicalement X
 - d- Le score de Fernandez permet de calculer la pertinence du traitement médical ✓
- 34- Quelles sont les causes d'aménorrhée avec FSH et LH élevées :
- a- SOPK X
 - b- Hyperplasie congénitale des surrénales X
 - c- Syndrome de Turner ✓
 - d- Altération ovarienne par radiothérapie ✓
- 35- Une femme âgée de 51 ans vient en consultation pour son suivi gynécologique de routine c'est une G3P3 aux ATCD de dyslipidémie et migraine, l'examen gynécologique est sans particularité, l'échographie pelvienne retrouve une image latéro-utérine avec des critères de malignité quel examen complémentaire prescrivez-vous :
- a- Une IRM abdomino-pelvienne .
 - b- Un téléthorax et une échographie hépatique
 - c- Une biopsie de la masse ovarienne
 - d- Un dosage du ca125
- 36- Les examens complémentaires sont en faveur d'une tumeur maligne de l'ovaire le ca125 est à 327 ui/ml, pour quelle raison le ca125 peut être augmenté :
- a- La tuberculose
 - b- Seuls les cancers de l'ovaire peuvent causer une nette augmentation surtout en stade avancé ✓
 - c- L'endométriose
 - d- Le cancer colorectal
- 37- Votre patiente est classée Ic ; ce si signifie :
- a- Qu'il y a atteinte d'un seul ovaire avec atteinte de la trompe X II
 - b- Qu'un seul ovaire est atteint et absence d'ascite et capsule intact X C
 - c- Qu'il y a atteinte d'un seul ovaire avec rupture capsulaire ✓
 - d- Qu'il y a atteinte d'un seul ovaire avec atteinte de l'utérus X II
- 38- Votre patiente est orientée dans un centre spécialisé en cancérologie votre prise en charge va être :
- a- Une chimiothérapie première pour éviter l'essaimage lors de l'intervention chirurgicale
 - b- Une coelioscopie exploratrice avec biopsie de la masse et chimiothérapie en second lieu
 - c- Une coelioscopie avec annexectomie et cytologie péritonéale et reprogrammer la patiente dans un second temps pour compléter le geste selon le type histologique de la tumeur ✓
 - d- Une chimiothérapie combinée à une radiothérapie première avant tout geste chirurgical X
- 39- Votre patiente a terminé son traitement et souhaite savoir quelle sera sa surveillance :
- a- Il est nécessaire de réaliser une échographie pelvienne annuelle X
 - b- Une IRM tous les deux mois X
 - c- La surveillance est principalement clinique aidée du suivi par le CA 125 ✓
 - d- Le suivi n'est pas nécessaire vu le stade précoce de la maladie X

40- Au cours de la consultation vous revoyez la patiente accompagnée de sa fille aînée qui est mariée et étudiante en médecine, elle est inquiète pour sa mère et pour elle-même et souhaite vous poser quelques questions, quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) :

- a- La fille doit faire en urgence un bilan oncogénétique x
- b- Qu'un parcours de procréation médicalement assistée augmente le risque du cancer de l'ovaire ✓
- c- La prise de contraception oestroprogestative protégerait du cancer de l'ovaire ✓
- d- La fille doit bénéficier d'un bilan précoce à base de HER4 et échographie pelvienne ✓

41- Une femme de 30 ans G3P2 aux antécédents de deux accouchements par voie basse sans complication d'enfants à poids eutrophe, vient à 38SA en consultation pour l'apparition de contraction utérine rapprocher et écoulement liquidien lors de votre examen clinique vous retrouver une présentation de siège :

- a- Cette présentation à ce terme est définitive
- b- Vous programmer une césarienne lors de cette consultation x
- c- Vous décidez de réaliser une version par manœuvre externe vu la multiparité et l'absence d'antécédents péjoratifs x
- d- Vous admettez votre patiente au bloc d'accouchement pour une épreuve de travail

42- Parmi les propositions suivantes concernant la lymphangite en cours d'allaitement laquelle(les) est, sont exacte(s) :

- a- Le sein est rouge et douloureux ✓
- b- Les antibiotiques sont possibles sans cesser l'allaitement ✓
- c- Les AINS sont interdits ✓
- d- La lymphangite s'accompagne d'une douleur pulsatile insomnante avec collection mammaire x

43- Vous recevez en consultation une femme de 57 ans pour une pesanteur pelvienne à l'examen clinique vous noter une cystocèle associée à un allongement hypertrophique du col et une colpocèle postérieure, comment faites-vous le diagnostic d'élytrocèle :

- a- Une Manométrieano-rectale
- b- Bilan urodynamique
- c- Un examen clinique sous valve
- d- Un toucher rectal combiner au toucher vaginal ✓

44- Vous en êtes en consultation et vous recevez madame X c'est une G4P3 sans antécédents particulier les accouchements précédents étaient de poids eutrophe sans complication, elle se présente en travail sur une grossesse à terme lors de votre examen vous constatez que c'est une présentation transverse avec une dilatation à 4 cm et à l'échographie vous avez un fœtus de poids eutrophe (estimation de poids de 3k500) :

- a- Vous accordez une épreuve de travail vu la multiparité et le poids eutrophe estimé échographiquement x
- b- Vous faite un pronostic d'accouchement et surveiller la parturiente en salle de travail x
- c- Vous accordez la parturiente en salle de travail et vous réalisez une version par manœuvre interne grande extraction de siège à dilatation complète x
- d- L'une des complications à redouter est l'épaule négligée ✓

45- Quel est le diamètre d'engagement dans la présentation de face :

- a- Le diamètre scincipito-mentonnier
- b- Le diamètre sous mento bregmatique ✓
- c- Le diamètre scincipito présternal.
- d- Le diamètre thoraco céphalique.

46- Dans le cycle menstruel :

- a- Les menstruations annoncent le début du cycle. ✓
- b- Les œstrogènes sont libérés par le stroma ovarien. x
- c- Le pic œstrogène précède celui de progestérone. ✓

- d- Dans la phase sécrétoire, les glandes endothéliales se ratatinent au début de la phase X
- 47- Le fibrome utérin :
- a- C'est une prolifération régulière des cellules musculaires striées X
 - b- La plupart des fibromes se révèlent par les signes de compression des organes de voisinage X
 - c- Actuellement l'hystérocopie est l'examen clé pour diagnostiquer les fibrome type : 0 1 2. ✓
 - d- IRM est réservée pour les gros fibrome venant en contact avec les organes de voisinage pelviens. ✓
- 48- L'accouchement dans la présentation de face par voie basse, est autorisé chez :
- a- La grande multipare dans la variété antérieure. ✓
 - b- La primipare dans la variété postérieure. X
 - c- La primipare dans la variété antérieure. X
 - d- La paucipare dans la variété postérieure. X
- 49- Une femme de 42 ans, G8P8 venant en consultation pour une anémie chronique secondaire à des ménorragies de moyenne abondance, chez elle on a diagnostiqué un fibrome type 4 de 7 cm de diamètre, quel est le traitement le plus convenable à proposer chez elle : *intra mûr*
- a- Un traitement médical par les macroprogestatifs. X
 - b- Un traitement chirurgical conservateur X
 - c- Un traitement chirurgical radical. ✓ G8P8
 - d- Un traitement médical par les oestroprogestatifs X
- 50- Dans l'accouchement de face, les signes de dystocie sont :
- a- Rupture de la poche des eaux à une dilatation précoce. ✓
 - b- Dilatation trainante du col utérin. ✓
 - c- Une dilatation complète avec une tête non engagée. ✓
 - d- Une rupture prématurée des membranes. ✓
- 51- Madame XX, âgée de 58 ans avec un adénocarcinome utérin moyennement différencié confirmé à la lecture histologique, classée stade I à l'IRM, pas de métastase à distance, le traitement peut comporter :
- a- La chirurgie radicale avec la radiothérapie. ✓
 - b- La chirurgie conservatrice. *D. 1. 2*
 - c- La chimiothérapie seule.
 - d- La chimiothérapie avec l'hormonothérapie.
- 52- Dans la folliculogénèse :
- a- Le phénomène de dégénérescence débute à la puberté. X
 - b- Un follicule primaire donne un follicule secondaire puis tertiaire. ✓
 - c- Le follicule de Graff est responsable de la sécrétion des hormones sexuelles. ✓
 - d- Le rétrocontrôle négatif est indispensable pour la libération du pic LH. ✓
- 53- Dans le carcinome épidermoïde :
- a- L'évolution des lésions précancéreuses vers le cancer est très rapide. X
 - b- Le frottis cervico-vaginal est un moyen de dépistage. ✓
 - c- L'aspect normal du col utérin à l'examen clinique au spéculum permet d'éliminer le cancer. X
 - d- L'ulcération est parmi les lésions typiques du cancer du col utérin. ✓
- 54- Dans la souffrance fœtale aigüe, quel est le premier signe clinique à rechercher :
- a- Le tracé plat à l'ERCF. X
 - b- La bradycardie fœtale.
 - c- L'émission du méconium. ✓
 - d- La pH métrie plus de 7,30 X
- 55- Pour l'adénocarcinome utérin : *endométr*
- a- Le point de départ est le myomètre.

- b- Il est favorisé par le climat hormonal de l'hyperoestrogénie relative.✓
- c- L'aspect végétant et hypervascularisé est évocateur à l'hystérocopie.✓
- d- Le type histologique bien différencié est de mauvais pronostic.✗

56- Le score biophysique de Manning :

- a- C'est un moyen de surveillance du bien être fœtal.✓
- b- Comporte 5 paramètres.✓
- c- Un score à 3 est bon.✗ 0-10
- d- C'est un score clinique.✗

57- Une femme enceinte de 7 SA, de Rhésus négatif qui n'a pas reçu sa dose anti-D après son dernier accouchement d'un bébé de Rhésus positif :

- a- Cette grossesse est à haut risque.✓
- b- Le bébé risque de faire une anémie en intra-utérin s'il est de rhésus positif.✓
- c- L'anasarque fœto-placentaire peut arriver si l'anémie est corrigée.✗
- d- On doit lancer le RAI test chez elle au cours du premier trimestre.✓

58- Dans le cancer du col utérin :

- a- Il existe plusieurs types de papillomavirus dont les plus cancérogènes : 11/18.✗ 16/18
- b- L'IRM abdomino-pelvienne permet de classer le stade évolutif de la tumeur.✓
- c- Le traitement s'adapte en fonction de l'âge de la patiente.✗
- d- Actuellement la prévention repose sur le dépistage par le FCV et la vaccination.✓

59- Dans la souffrance fœtale chronique :

- a- La complication la plus redoutable est le retard de croissance.✓
- b- La perturbation du doppler ombilical est parmi les signes d'une mauvaise évolution.✓
- c- Le liquide teinté est un signe clinique de cette souffrance.✓
- d- L'interruption de grossesse dépend de l'âge gestationnel, la sévérité de la souffrance.✓ > 20 30

60- Une femme XX, primipare, de race noire, arrivant à l'urgence avec une grossesse de 27 SA pour des céphalées intenses, à l'inspection on note la présence des œdèmes des membres inférieurs et du visage, avec une Tension artérielle : 18/10 à deux reprises séparées par 15mn d'intervalle, quel est le diagnostic à évoquer chez elle :

- a- HTA chronique.✗
- b- HTA gravidique légère.✗
- c- HTA gravidique sévère.✓
- d- HTA chronique sévère.

61- On a demandé une protéinurie de 24h revenant à 750mg, quel est le type de cette HTA :

- a- HTA gravidique compliquée d'une pré-éclampsie
- b- HTA chronique avec une pré-éclampsie surajoutée.✗
- c- Pré-éclampsie pure.✓
- d- HTA transitoire.✗

62- Quelles sont les démarches de la prise en charge chez elle :

- a- Hospitalisation avec un traitement anti-hypertenseur administré par voie orale.✗
- b- Hospitalisation, on jugule d'urgence par l'administration d'un traitement anti-hypertenseur par voie IV puis le relais par voie orale et on commence par un anti-inhibiteur central sous réserve d'un bilan hépatique normal.✓
- c- Demande d'un bilan HTA.✓
- d- Le sulfate de magnésium serra administrer jusqu'à la disparition des céphalées.✓

63- Les résultats du diagnostic sérologique de la toxoplasmose conduisent aux conclusions suivantes ; laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- a- Une sérologie négative oblige à la surveillance sérologique régulière tout au long de la grossesse.✗
- b- Une sérologie positive chez le nouveau-né signe obligatoirement une toxoplasmose évolutive.✓

- c- Une sérologie négative chez la femme enceinte oblige à donner des conseils prophylactiques stricts ✓
- d- Une sérologie négative oblige à l'administration du vaccin antitoxoplasme ✗
- 64- Parmi les propositions suivantes relative à la délivrance laquelle (lesquelles) est(sont) exactes :
 - a- Le clivage de la zone utérine se fait entre la zone compacte et la zone spongieuse ✓
 - b- La reprise clinique de contractions utérine survient après un repos de 10 à 15min ✓
 - c- L'hémostase définitive est assurée par la ligature vivante de Pinard ✓
 - d- Dans le mode Baudelocque le placenta est propulsé face maternelle en premier ✗
- 65- Concernant la délivrance :
 - a- Dans la délivrance spontanée le placenta est évacué sous l'effet de la gravité ✓
 - b- Dans la délivrance dirigée l'expulsion est aidée par une tierce personne ✗
 - c- La délivrance dirigée se fait par voie intraveineuse au moment de dégagement de l'épaule antérieure du fœtus ✓
 - d- La délivrance artificielle correspond à l'extraction manuelle du placenta hors de l'utérus ✓
- 66- La grossesse molaire :
 - a- Est l'entité la plus fréquente des maladies gestationnelles trophoblastiques ✓
 - b- Il s'agit d'une dégénérescence kystique des villosités placentaire
 - c- Elle peut être partielle ou complète ✓
 - d- Dans la mole complète l'évacuation doit-être faites par aspiration sous contrôle échographique ✓
- 67- Dans la Toxoplasmose :
 - a- Le mode de transmission est la Voie digestive ✗
 - b- Le mode de transmission est la Voie respiratoire ✗
 - c- Devant des IgG - /IgM - la femme n'est pas immunisée ✓
 - d- Devant des IgG + /IgM - la femme est immunisée .
- 68- La Toxoplasmose congénitale peut provoquer :
 - a- Un avortement ✓
 - b- Un retard de croissance intra utérin
 - c- Une hydrocéphalie ✓
 - d- Des calcifications intra crânienne ✓
- 69- En l'absence d'immunité toxoplasmique quelles sont les mesures préconisées :
 - a- Lavage soigneux des fruits et des légumes ✓
 - b- Il n'y a pas de risques de contamination. ✗
 - c- Port de gants pour jardiner est obligatoire ✓
 - d- Le contact avec les chats est à éviter ✓
- 70- Dans la Rubéole :
 - a- L'agent pathogène est un virus strictement humain ✓
 - b- Le virus de la rubéole se propage par contact humain direct par voie respiratoire ✓
 - c- Le mode de contamination est la Voie digestive ✗
 - d- La prévention primaire repose sur la vaccination ✓
- 71- Dans la Rubéole congénitale :
 - a- Le risque d'infections augmente avec l'âge gestationnel
 - b- Le risque d'infections diminue avec l'âge gestationnel ✓
 - c- Le fœtus peut avoir une atteinte auditive ✓
 - d- Il n'y a pas de conséquences sur le fœtus en cas de rubéole congénitale ✗
- 72- Dans la Listériose :
 - a- Il faut penser à la Listériose en cas de fièvre et grossesse ✓
 - b- Le diagnostic est essentiellement bactériologique ✓
 - c- Ses conséquences fœtale et néonatale sont généralement bénignes ✗
 - d- L'Amoxicilline (pénicilline) est le TRT de référence ✓
- 73- L'infection urinaire durant la grossesse :
 - a- La cystite est une infection urinaire basse localisé à la vessie ✓

- b- Elle se manifeste par des brûlures mictionnelles une fièvre, une pollakiurie ✓
c- S'accompagne de contractions utérines et de modification cervicales ✓
d- Elle n'a pas d'impact sur la grossesse ✗
- 74- L'infection urinaire pendant la grossesse peut être responsable des complications comme :
a- Une mort fœtale in utero
b- Un accouchement prématuré ✓
c- Un choc septique maternel
d- Une malformation fœtale
- 75- L'hémorragie de la délivrance est :
a- Principale cause de mortalité maternelle ✓
b- Dans les 2/3 des cas est évitable
c- Dites grave lorsqu'elle dépasse les 1500cc lors de la césarienne ✓
d- Survient dans les 24hr qui suit l'accouchement ✓
- 76- Les étiologies de l'hémorragie de la délivrance sont :
a- Atonie utérine ✓
b- Déchirure cervicale ✓
c- Thrombopénie ✓
d- Fibrome prævia
- 77- Le diagnostic de l'Adénomyose peut se faire par :
a- Écho 3D ✓
b- TDM
c- IRM ✓
d- Hystérosonographie
- 78- Toutes les propositions concernant l'endométriose externe sont justes sauf une laquelle :
a- Touche 1e femme sur 10 .
b- Touche le pelvis l'ovaire et autres localisations
c- La grossesse est responsable d'un accroissement des lésions ✓
d- Principale étiologies d algies pelvienne chronique
- 79- Les indications de curetage utérin hémostatique sont :
a- Œuf clair ✓
b- Avortement tardif ✗
c- Rétention placentaire
d- Grossesse molaire invasive ✓
- 80- Les complications à court terme de curetage sont :
a- La synéchie ✓
b- L'infection ✓
c- La perforation ✓
d- La cloison



Gynécologie - Obstétrique, programme d'examen 'Examen', de la : Cinquième année de Méd

Date de l'épreuve : 09/03/2023

Corrigé Type

Barème par question : 0,250000

N°	Rép.
1	C
2	AB
3	BCD
4	ABC
5	CD
6	CD
7	ABCD
8	ACD
9	BD
10	C
11	AD
12	D
13	BC
14	AC
15	B
16	AD
17	D
18	ABD
19	CD
20	C
21	AD
22	AD
23	CD
24	B
25	AC
26	C
27	BCD
28	ABC
29	BD
30	BC
31	ABC
32	B
33	CD
34	CD
35	AD

N°	Rép.
36	AC
37	C
38	C
39	C
40	BC
41	A
42	AB
43	D
44	D
45	B
46	AC
47	CD
48	A
49	B
50	ABCD
51	A
52	BCD
53	BD
54	C
55	BC
56	AB
57	ABD
58	BD
59	ABCD
60	C
61	C
62	BCD
63	AC
64	AB
65	ACD
66	ABCD
67	ACD
68	ABCD
69	ACD
70	ABD

N°	Rép.
71	BC
72	ABD
73	ABC
74	ABC
75	ABCD
76	ABCD
77	AC
78	C
79	AC
80	BC